

Université Constantine 3. Faculté de médecine.
Département de médecine.
Enseignement de 3ème année médecine.
Année universitaire 2024-2025.

Dr Kerouaz Nassera

Rédiger une observation médicale (1)

Objectifs pédagogiques

- ✓ Savoir définir qu'est une observation médicale.
- ✓ Savoir construire une observation.
- ✓ Savoir mener un interrogatoire.
- ✓ Comprendre le déroulement d'un examen clinique.
- ✓ Savoir construire une synthèse et une conclusion du cas.

Plan

I. Introduction

- 1) *Définition de l'observation*
- 2) *Principes fondamentaux*
- 3) *Structure de l'observation*

II. Anamnèse

- 1) *Identification*
- 2) *Motif de consultation*
- 3) *Antécédents (ATCD)*
 - a) ATCD personnels**
 - Médicaux
 - Allergies
 - Vaccinations
 - chirurgicaux
 - gynéco- obstétriques
 - b) ATCD familiaux**
- 4) *Histoire de la maladie:*
- 5) *Habitudes de vie*
- 6) *Conditions socio-économiques*
- 7) *Anamnèse orientée*
 - a) *Signes généraux*
 - b) *Signes fonctionnels*

III. Conclusion

I. Introduction

1) Définition

Savoir rédiger une observation est essentielle, elle doit être **claire et précise**.

Une observation médicale est **un document rédigé par un médecin** selon une méthodologie particulière, à la suite de l'examen clinique d'un patient, permettant d'organiser sa réflexion de manière logique, dans le but d'aboutir à un diagnostic et de proposer une prise en charge.

Une observation médicale **joue un rôle primordial dans un dossier médical**, puisqu'elle permet une **transmission des informations efficace entre les professionnels de santé** et favorise un suivi optimal dans le temps.

C'est un **document officiel sur le plan médico-légal**, il est considéré comme une trace écrite de l'examen et du problème clinique permettant de justifier la prise en charge.

2) Principes fondamentaux de l'observation

- Le médecin doit être un bon observateur avoir le souci du détail : remarquer l'aspect pale du patient, semble endormi ou agité.
- Ecrire lisiblement et prendre le temps de rédiger directement au chevet du patient, les observations sont de plus en plus informatisées
- Eviter les abréviations sauf celles qui sont répertoriées en médecine : HTA, HIC, FRCV...
- Plan doit être bien visible
- Pas de syndromologie en sémiologie mais les signes du syndrome
- Acquisition du vocabulaire médical, éviter les termes non médicaux
- Reconstitution en un ensemble cohérent des informations diffractées en appareil par appareil.

3) Structure de l'observation médicale

Elle comporte plusieurs rubriques dans un ordre précis:

- Date et Identification du clinicien
- Entretien (anamnèse systématique et anamnèse orientée)
- Examen clinique
- Résultats des examens complémentaires déjà effectués : biologie, imagerie, endoscopie ou autre;
- Conclusion: résumé et regroupement syndromique, hypothèses, étiologiques argumentées, conduites à tenir diagnostique et thérapeutique.

II. Anamnèse

L'entretien avec le patient permet de recueillir un certain nombre de données comme l'identification du patient, les signes fonctionnels, le motif de consultation, l'histoire de la maladie, nécessaires au diagnostic.

Il faut s'assurer de la faisabilité de l'anamnèse (patient coopérant, pas d'urgence vitale)

1) Identification

- S'identifier en inscrivant la date de l'observation, le nom et fonction du clinicien (externe, interne....)
- Données civiles du patient : Nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, sexe, marié célibataire, enfants
- Adresse/téléphone
- Profession

2) Motif de consultation:

- La raison pour laquelle la personne est venu consulter ou est hospitalisée, il peut s'agir de signes subjectifs (douleur, asthénie) ou objectifs (hématémèse, toux)
- Il peut aussi s'agir d'une hospitalisation programmée : exploration, traitement

Mr, Mme..., âgé de ...consulte pour ou admis au service de.....

3) Histoire de la maladie:

- Reconstituer de façon chronologique l'histoire récente tout en décrivant la plainte du patient qui peut être recueillie auprès de l'entourage
 - Mode d'installation et critères du trouble : date de début, type, durée, localisation, intensité,...)
 - Signes associés
 - Facteurs déclenchant ou soulageant
- Exemple : le début de la symptomatologie semble remonter à (date).... marqué par l'installation

4) Antécédents (ATCD)

a) ATCD personnels

- Médicaux: affections passées, date, traitement
- Allergies et traitements reçus
- Vaccinations
- Chirurgicaux: le type d'intervention en termes chirurgicaux, la chronologie, le site anatomique, les éventuelles complications du geste opératoire.
- ATCD gynéco-obstétriques : ménarche (date des premières règles), gestes, parité, date des dernières règles (vérifier l'absence de grossesse si un traitement ou examen radiologique doit être prescrit), avortement, contraception

b) ATCD familiaux, consanguinité, MFH, génétiques, Cancer, mentales, - métaboliques, arbre généalogique si maladies héréditaires

5) Habitudes de vie

- Habitudes alimentaires : régime pour une obésité et ou un diabète et ou une carence
- Loisirs : activité physique
- Facteurs de risque: tabac, dyslipidémie, alcool, HTA, diabète, toxiques

6) Conditions socio-économiques : ou statut épidémiologique

- Conditions géographiques: origine
- Habitat et condition d'habitation : urbaine, rurale, nombre de chambre, nombre de personnes dans la famille, éclairage, source d'eau,
- Notion de contagion tuberculeux
- Animaux domestiques : pouvant être source d'allergies ou de transmission de maladies
- Ressources économiques : le patient ne peut se permettre une prise en charge coûteuse, n'a pas les moyens de s'alimenter correctement expliquant par exemple un amaigrissement isolé.
- Situation sociale; divorce, veuvage
- Niveau culturel et scolarisation

7) Anamnèse orientée

- a) Signes généraux: amaigrissement, asthénie, anorexie, fièvre, poids taille
- b) Signes fonctionnels de chaque appareil (organe) en commençant par la zone d'appel en souffrance ou qui a motivé la consultation

Préciser les caractéristiques sémiologiques de chaque signe fonctionnel présent et noter aussi les signes absents chez le patient et ceci pour chaque appareil.

III. Conclusion

Résumé de l'anamnèse